

24 呼吸器疾患の緩和ケア palliative care

A

悪性腫瘍 malignant tumors

到達目標

- ・早期からの緩和ケアの重要性が理解できる
- ・疼痛・せん妄の症状マネジメントができる
- ・適切な予後予測をふまえた治療選択ができる

1 早期からの緩和ケアの重要性

進行肺癌の「診断時」から専門的緩和ケアが介入することの有用性を示した Temel らの報告に代表されるように、いまや「癌治療と緩和ケアの統合」は世界の標準となっている。その際の緩和ケアとは、後述する疼痛など苦痛症状のマネジメントや心理社会的サポートのみならず、正しい病状の理解に基づく適切な治療選択の支援も含まれている¹⁾。近年は分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬の発達により、進行肺癌患者でも治療期間が数年間に及ぶことが珍しくない。主治医が抗癌治療のみに執着して緩和ケアへの意識が疎かになると、患者自身も「抗癌治療の中止＝治療の失敗」と捉え、緩和ケアに対してネガティブな印象を持ち、結果的にホスピスや在宅緩和ケアなどへの適切な移行が妨げられる。米国臨床腫瘍学会のガイドラインでも、治療中の患者とのコミュニケーションにおいて表1に示す内容が重要としており、それらは近年啓蒙活動が盛んなアドバンス・ケア・プランニング（ACP）（終末期における治療・療養方針を患者・家族と医療者が話し合う自発的なプロセス）にも重なる²⁾。ACPは、余命1年以内と予測された比較的体調がよい時期に主治医が行うのが理想であるが、必要に応じて緩和ケアの専門家と積極的に連携をはかることが望ましい。当然ながら「悪い知らせ」を伝える機会が多い医師は、優れたコミュニケーションスキルを身につける必要があり、日本の患者に対する有用性が示された SHARE（表1）などを踏まえ日々研鑽を積むことが求められる³⁾。

以下に、癌患者の終末期に生じやすい苦痛症状のうち、疼痛とせん妄への対処法を述べる（呼吸困難への対処法は次項を参照）。

2 がん疼痛の症状マネジメント

腫瘍の進展によって生じた疼痛は、治療の初期段階では抗癌治療による腫瘍縮小で改善したり、骨転移など病巣が限局している場合には放射線照射が奏効した

表1 がん患者とのかかわりにおいて重視すべき点

・治療の目標と予後に関する話し合い ・治療選択 ・終末期のケア ・患者のケアに家族がかかわるよう促すこと ・治療医のコミュニケーションスキルトレーニング （日本では以下の SHARE が推奨される）	
Setting	適切な場の設定
How to deliver bad news	悪い知らせの伝え方への配慮
Additional information	（患者が望む）情報を与える
Reassurance and	今後に対する希望の提供
Emotion	患者の情緒に共感的に対応

りもするが、多くの場合には鎮痛薬が治療の中心となる。第1段階として、acetaminophen もしくは非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）を十分量（acetaminophen の場合 2,000 mg/day 以上）用いる。第1段階の鎮痛薬で十分な症状緩和が得られない場合は、躊躇せずオピオイドを試みるべきであり、疼痛の程度によって第2段階の弱オピオイド（codeine, tramadol など）か、第3段階の強オピオイド（morphine, oxycodone など）への移行を検討する（いずれも相乗効果を期待して第1段階の鎮痛薬に「上乗せ」する）。「びりびりした」しびれや電撃痛、「じんじんした」灼熱感など神経障害性疼痛の症状も伴う場合には pregabalin などの鎮痛補助薬も有用だが、その際も、まずはオピオイドなどの効果を確認したうえで併用する⁴⁾。

オピオイド処方時は、持続痛に対する徐放性製剤と突出痛に対する速放性製剤（レスキュー）を組み合わせるのが基本であり、前日のレスキューの使用量を参考に当日の1日量を決定する。レスキューの1回量は経口剤であれば1日量の1/6、注射剤による持続投与の場合は同じく1時間量（1日量の1/24）が目安とされるが、いずれも使用後の効果を必ず確認し（numerical rating scale : NRSなどを指標とする）、効果不十分であれば1回量の増量を検討する。順調であれば数日以内にレスキューが日に数回以内で安静時の大半を苦痛なく過ごせるようになるが、安静時痛が軽減せずレスキューの効果も乏しい場合には当該オピオイドによる鎮痛に固執せず、オピオイドスイッチングや他の鎮痛手段（神経ブロックなど）を検討する必要がある。なお、せん妄の合併で疼痛への閾値が下がっ